Урок 5.1.

Пищевая непереносимость в нутрициологии





Алёна Вавилова

клинический нутрициолог, health-coach
и спикер по вопросам здоровья

- Более 6 лет опыта в нутрициологии и более 200 довольных клиентов с позитивными результатами
- Автор информационных продуктов в сфере ЗОЖ и разработчик добавок и продуктов для здоровья
- Основатель профессионального сообщества нутрициологов Москвы и член Международной ассоциации нутрициологов и коучей

О чем этот урок?

1. Немного теории и мой опыт работы с тестами
2. Кейс 1: трещины на пальцах и пищевая непереносимость
3. Кейс 2: высыпания на теле и отёчность
4. Кейс 3: дерматит и “вес стоит”
5. Мой кейс: аутоиммунный тиреоидит, РПП и поллиноз

Как и с кем я работаю

Веду частную практику, ранее работала в клинике вместе с превентивными врачами.

Мои клиенты — взрослые от 20 до 45 лет.

Я не работаю с детьми, подростками, беременными, женщинами и мужчинами в период мено-/андро- паузы.

Чаще всего

ко мне обращаются с запросами:

- "красные" анализы: дефицит железа, аутоиммунные процессы
- проблемы с кожей: акне, дерматиты, неровный тон, розацеа, купероз
- выпадение волос
- снижение энергии и усталость
- лишний вес

Симптомы и жалобы

чаще всего сочетаются с жалобами на ЖКТ:

– тонзиллиты и неприятные ощущения в области рта и носоглотки, связанные с ГЭРБ

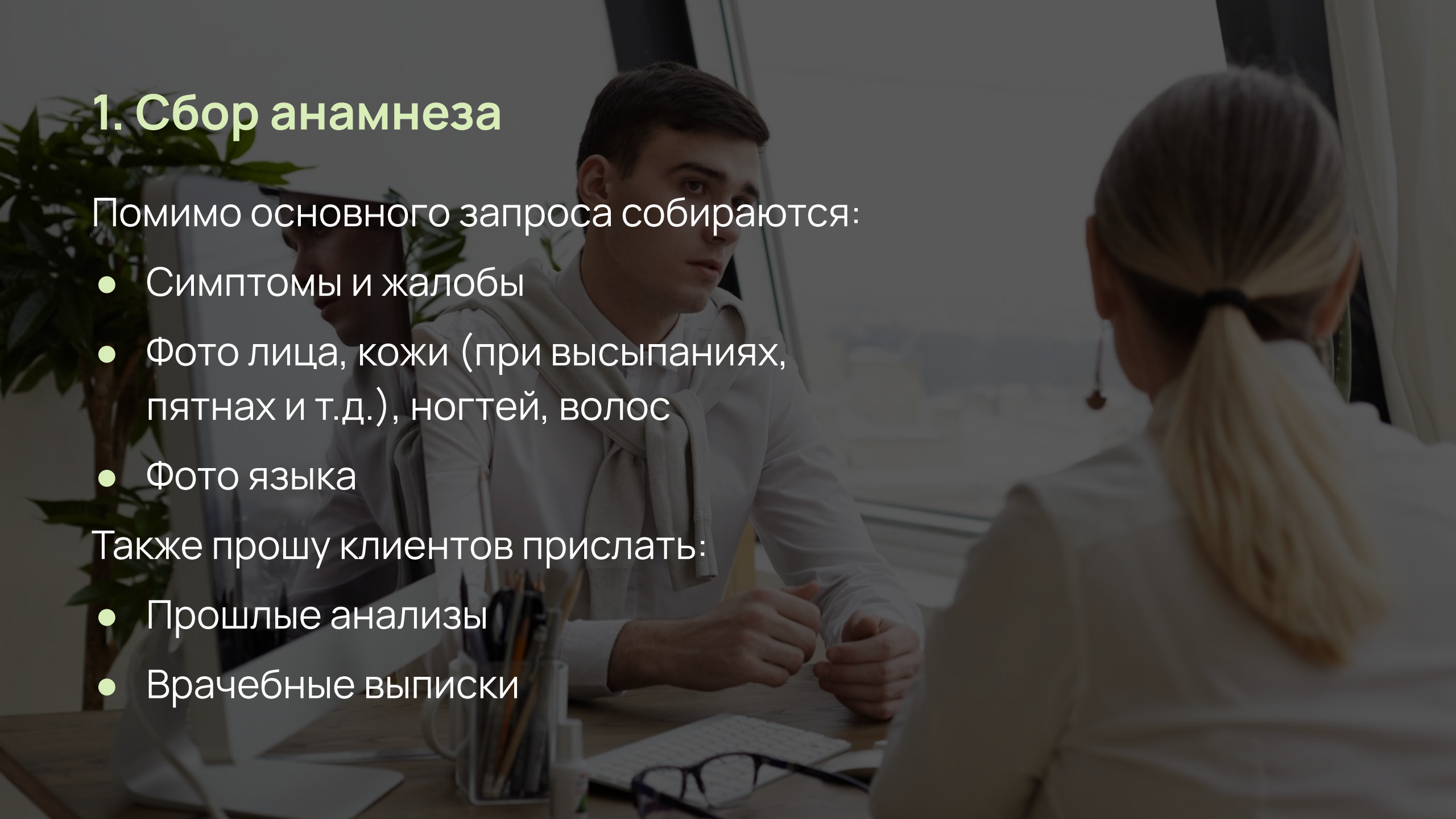
– вздутие, тяжесть после еды, непереносимость отдельных продуктов

– запоры или наоборот — слишком частый/жидкий стул

– изжога

Мой подход

5 шагов нутрициолога для глубокой и эффективной работы с клиентом



1. Сбор анамнеза

Помимо основного запроса собираются:

- Симптомы и жалобы
- Фото лица, кожи (при высыпаниях, пятнах и т.д.), ногтей, волос
- Фото языка

Также прошу клиентов прислать:

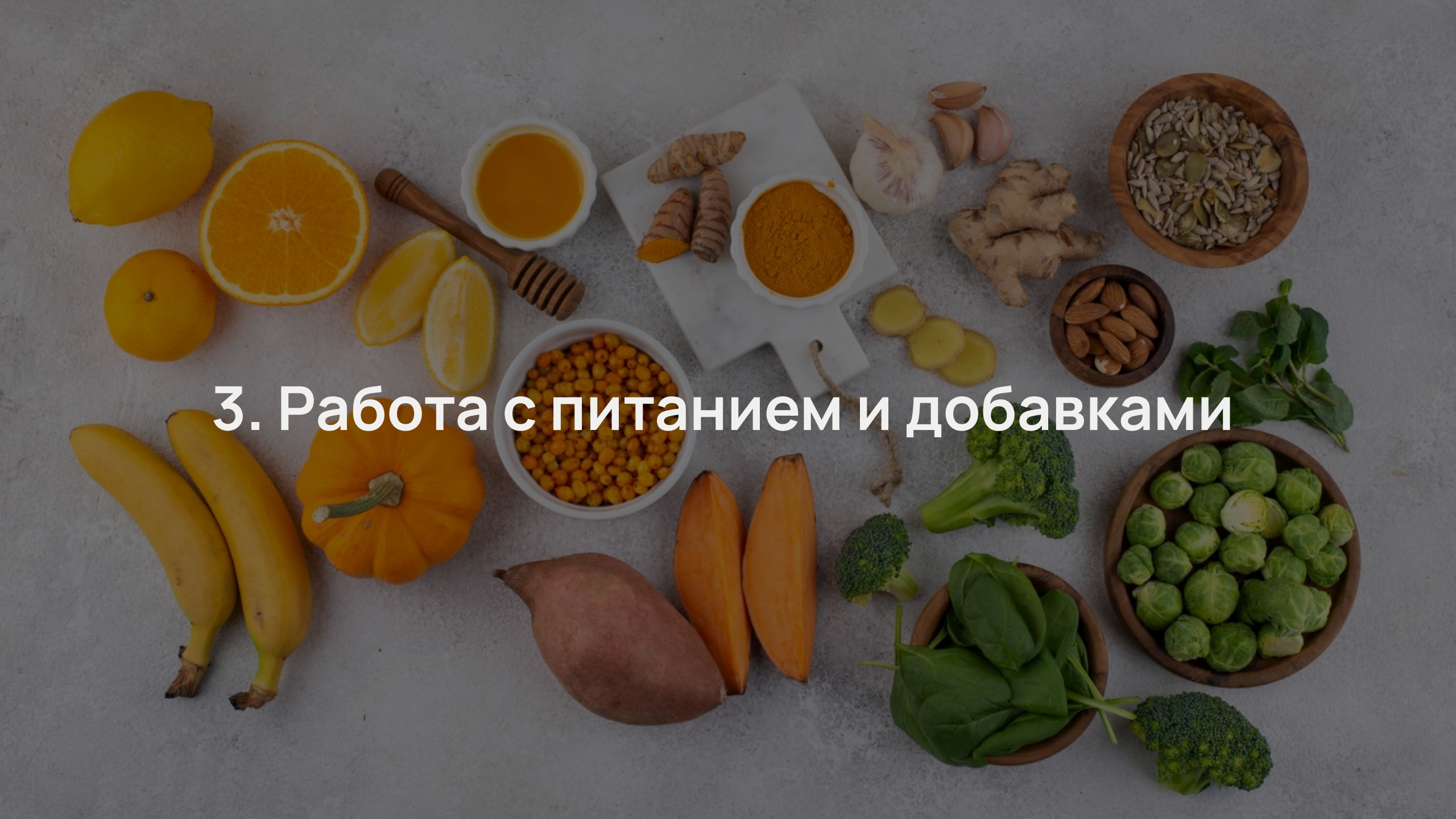
- Прошлые анализы
- Врачебные выписки

2. Анализ возможных причин

Если у клиента есть:

- ➔ Аутоиммунные заболевания
- ➔ Кожные проблемы (дерматиты, акне, псориаз, себорея, высыпания)

Часто это сигнал о **комплексных нарушениях ЖКТ** и возможно, потребуется прицельная работа с **пищевыми непереносимостями** в будущем



3. Работа с питанием и добавками

Питание и добавки

- Продолжительность: **2 недели – 1 месяц**
- Приоритет: сбалансированное питание, минимум сахара и промышленной еды
- Мягкое введение добавок (второстепенно, как поддержка):
  - ✓ Улучшение пищеварения
  - ✓ Адаптогены
  - ✓ Магний, витамин D, омега
  - ✓ Подготовка к глубинной работе (напр. поддержка слизистых в протоколе 5R)

Также на этом этапе

важна корректировка образа жизни:

- Гигиена сна
- Баланс труда и отдыха
- Ритуалы расслабления (дыхание, самомассаж, аппликатор Кузнецова, прогулки)

при необходимости добавляется:

- Массаж
- Остеопатия
- Висцеральная терапия
- Иглотерапия

4. Первые итоги

Уже на первых этапах:

- Улучшается работа ЖКТ
- Уходят кожные проявления
- Повышается энергия и мотивация

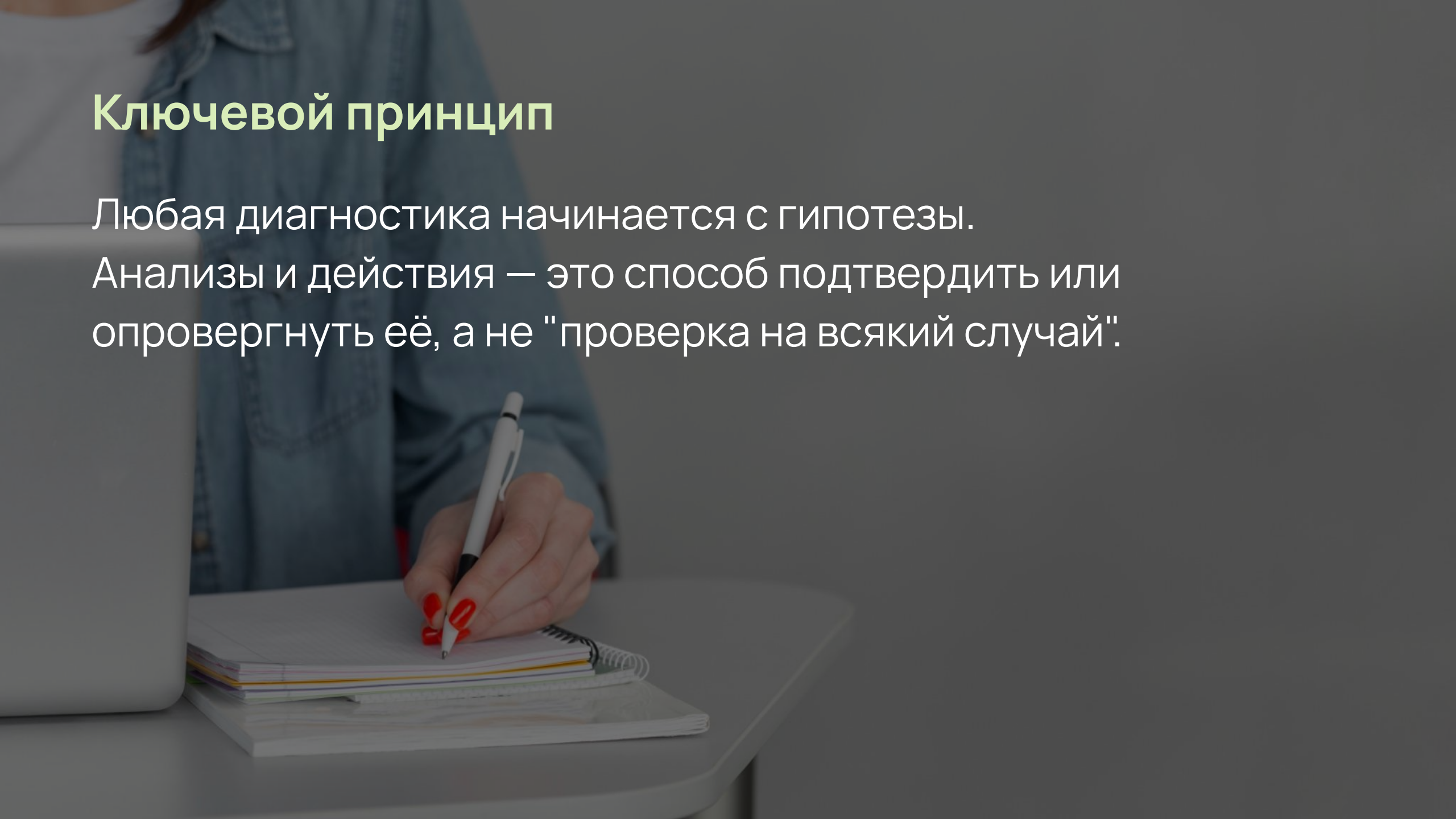
Но когда часть симптомов сохраняется и не уходит в ремиссию, важно выяснить их причины.

5. Диагностика и дальнейшая работа

На этом этапе я провожу **расширенную диагностику** и могу рекомендовать (или направить к специалисту):

- Тесты на пищевые непереносимости
- Проверку гормонального фона
- Анализ микробиоты
- Тестирование функций ЖКТ и другие специфические исследования

Эти методы относятся к более **дорогостоящим и точечным анализам**, и рекомендуются **только при наличии обоснованных гипотез**.



Ключевой принцип

Любая диагностика начинается с гипотезы. Анализы и действия — это способ подтвердить или опровергнуть её, а не "проверка на всякий случай".

Нутрициологи могут рекомендовать анализы, но **не имеют права их назначать**.

При каких симптомах я рекомендую тест?

- аутоиммунные заболевания, особенно АИТ в целях снижения антител
- кожные проявления, акне, высыпания неясной природы, дерматиты
- пищевая реактивность (покраснения, пятна, высыпания на лице и теле)
- поллиноз

Когда рекомендую тест?

- после проведения подготовительной работы с питанием, добавками, образом жизни
- после того, как клиент 1-2 месяца проведет на сбалансированном и относительно чистом питании
- работаю с пищевыми непереносимостями в комплексе с заживлении слизистых, коррекции микробиоты

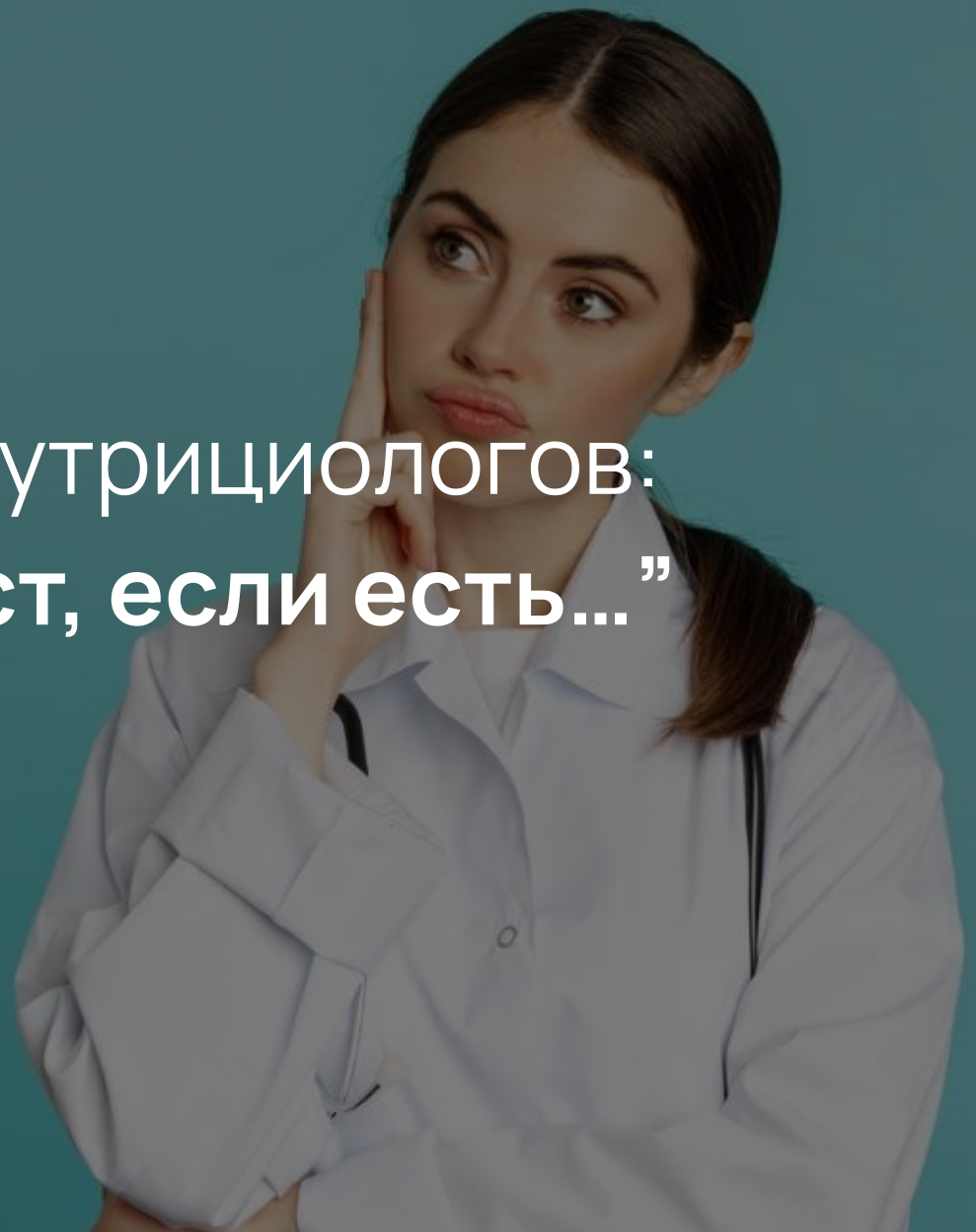


Я не рекомендую тест, если

- симптомы проходят на базовой коррекции рациона питания и образа жизни
- у клиента есть склонность к РПП или эмоциональному перееданию и ограничения в рационе вызывают срывы

Иногда слышу от нутрициологов:

“Зачем делать тест, если есть…”



...если есть:

1. Сбалансированное питание
2. Сбалансированное питание + исключение популярных триггерных продуктов
3. Элиминационная диета + интродукция с провокацией
4. Генетические тесты на пищевую непереносимость
5. Специализированные протоколы:
    - Столы Певзнера
    - низко- гистаминовая диета
    - аутоиммунный протокол
    - low FODMAP diet

Сбалансированное питание

по белкам, жирам, углеводам и клетчатке, с учетом индивидуальных особенностей:

- добавление клетчатки (овощей, зелени), медленных углеводов (круп), белков, чистой воды
- добавление новых категорий продуктов и блюд: бобовые, водоросли, кислые ягоды, новые напитки (цикорий, отвар шиповника, кофе из одуванчика, травяные чаи и пр.)



А также

- снижение потребления продуктов промышленного производства, сахара, некачественных продуктов молочной продукции, глютена и кофе
- введение гигиены питания: режим питания, процесс жевания, особенноси концентрации

Плюсы

- подходит широкому кругу людей
- у большинства клиентов происходит улучшение симптоматики по широкому спектру вопросов: изжога, вздутие, запоры, неоформленный стул, уровень энергии, тяга к сладкому, высыпания и тд.
- быстрые результаты укрепляют доверие, а также веру в свои силы справиться с задачами по здоровью

Минусы

- данного решения недостаточно при серьезных симптомах: акне, дерматитах, аутоиммунных заболеваниях, СРК и др.

Сбалансированное питание + исключение популярных триггерных продуктов:

- молочной продукции
- глютена
- сахара
- иногда: яиц и орехов

Плюсы

- положительный эффект есть только, если исключены все основные категории, которые дают значимую нагрузку на иммунную систему

Минусы

- эффект не стабилен (т.к. часто включает продукты на которые есть непереносимость)
- исключаются продукты, на которых может не быть непереносимости
- большинству людей сложно соблюдать такое питание, если исключены несколько крупных категорий продуктов, из-за чего эффективность может снизиться

Элиминационная диета + интродукция с провокацией

Она же элиминационно-реинтродукционная диета (ЭРД).

Это строгое исключение множества категорий продуктов на период элиминации от 2-х недель до 6-ти месяцев с последующим введением продуктов в рацион с провокацией.

Провокация и последовательное введение продуктов с промежутком в 3-4 дня помогает отследить реактивность на продукт.

Цель

Устранить системное хроническое воспаление в организме, которое возникло в результате употребления продуктов, вызывающих повышенную чувствительность, аллергию или непереносимость.

Плюсы

- позволяет выявить индивид. чувствительность к продуктам: как иммуннологическую непереносимость, так и аллергическую, связанную с чувствительностью к сахарам (фруктозе, лактозе, foodmap)
- может иметь схожий результат, с тестом на пищевую непереносимость

Минусы

- для большинства людей эта диета сложна в реализации
- легко пропустить неяркую симптоматику и “смазать” результат

Генетические тесты на “пищевую непереносимость”

HLA DQ2/DQ8 - показывает предрасположенность к целиакии (непереносимость глютена)

Генетические тесты, которые показывают активность ферментов:

- **LCT** - активность фермента, расщипляюего лакозу (молочный сахар)
- **CYP1A2** - активность фермента печени, который отвечает за переработку кофеина
- **ADH1B** - фермент, который участвует в метаболизме этанола (алкоголь)



Плюсы

- позволяет выявить часть предрасположенностей, на основе которых можно сформировать рацион питания и образ жизни

Минусы

- не информативен без сопутствующих диагностик
- охватывает только часть возможных реакций на еду
- не дает количественную информацию о снижении фермента

Столы Певзнера

это система лечебного питания, разработанная советским диетологом и терапевтом **Мануилом Исааковичем Певзнером** в 1920–1940-х годах.

Это **15 диетических столов**, каждый из которых соответствует определённому заболеванию или состоянию.

Эта система до сих пор используется в клиниках и санаториях постсоветского пространства, несмотря на устаревание части подходов



Плюсы

- хорошая основа для диетотерапии при острых состояниях
- можно адаптировать под клиента, доработав списки продуктов

Минусы

- не учитывают современных знаний о микробиоте, пищевой чувствительности, нутритивной поддержке
- не для персонализированного подхода
- устаревшие подходы к балансу тарелки: исключаются жиры, сырые овощи
- отсутствие понимания пищевых непереносимостей

Низкогистаминовая диета

это временное ограничение продуктов, богатых гистамином или провоцирующих его высвобождение.

Симптомы высокого гистамина схожи с симптомами пищевой непереносимости и аллергии.

Также используется при поллинозе и других состояниях для снижения выраженности симптомов

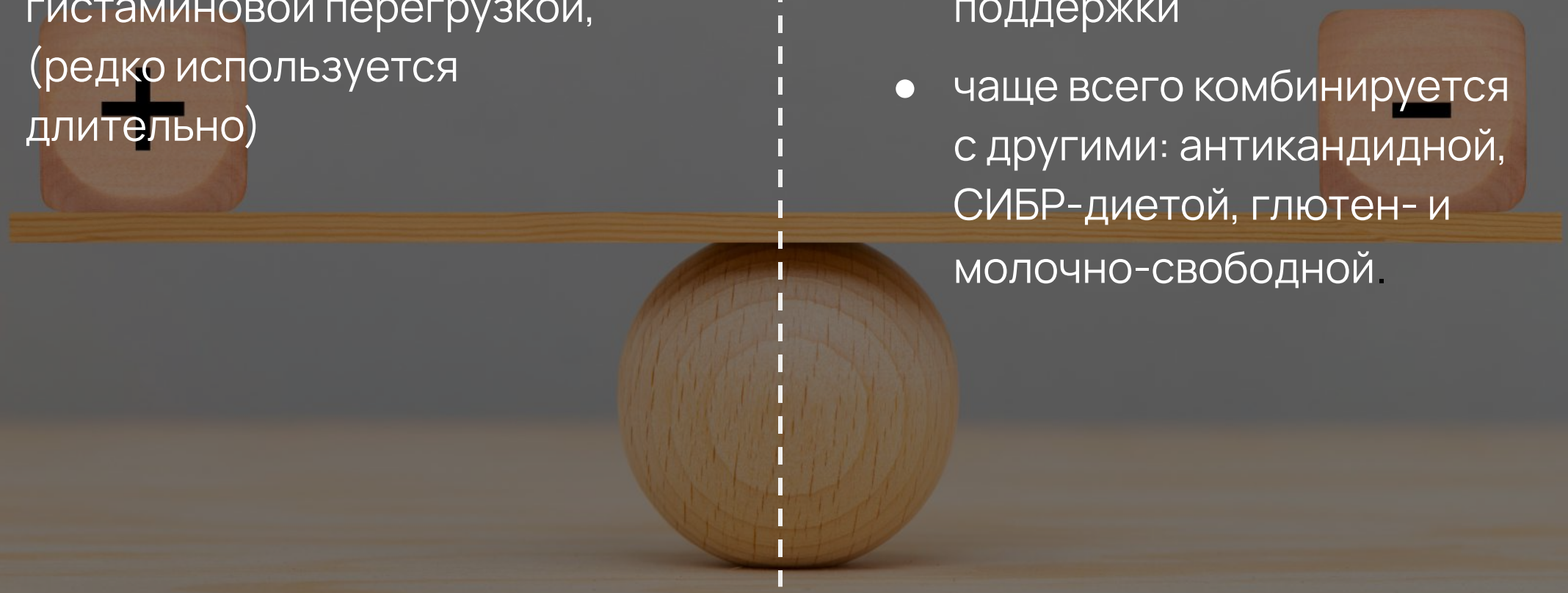


Плюсы

- временная диета для снятия симптомов связанных с гистаминовой перегрузкой, (редко используется длительно)

Минусы

- одна из самых сложных в соблюдении диет, требует поддержки
- чаще всего комбинируется с другими: антикандидной, СИБР-диетой, глютен- и молочно-свободной.



Аутоиммунный протокол

это набор ограничений и специальных правил в питании, которых нужно придерживаться для достижения результата.

Цель: снизить воспаление и иммунную активность при аутоиммунных заболеваниях, восстановить слизистую кишечника и барьеры.



Аутоиммунный протокол

это диета, при которой на срок от 3 до 6 мес (иногда дольше) исключаются следующие продукты:

- глютен
- злаки
- молочные продукты
- яйца
- бобовые (включая сою)
- пасленовые (помидоры, перец, баклажан, картофель)
- орехи и семена (в том числе специи из них)
- кофе
- алкоголь
- сахар
- промышленная еда

Плюсы

- позволяет снизить антитела и проявление аутоиммунных заболеваний, часто снижается отечность и проходят сопутсвующие симптомы

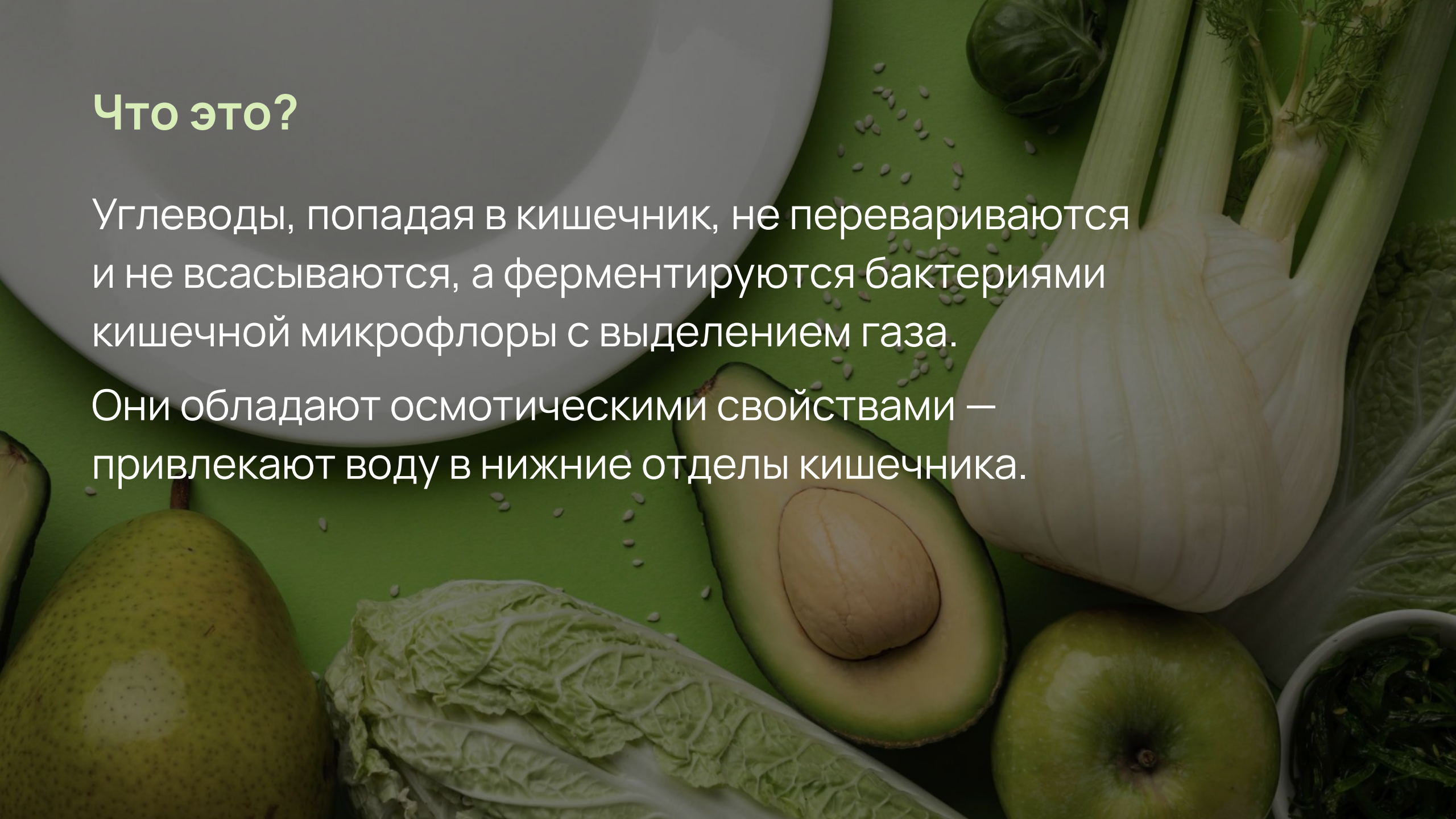
Минусы

- очень сложная в реализации для большинства людей
- дефицитарная диета по нутриентам (не рекомендуется длительно), при этом невозможно определить точно какие продукты стоит исключить пожизненно

Low FODMAP diet

Диета 3ех-этапная элиминационная диета, которая по длительности варьируется от 2-х до 6-ти недель с низким содержанием FODMAP.

Она была разработана для людей с нарушениями работы ЖКТ, включая синдром раздраженного кишечника, а также воспалительные заболевания кишечника.



Что это?

Углеводы, попадая в кишечник, не перевариваются и не всасываются, а ферментируются бактериями кишечной микрофлоры с выделением газа.

Они обладают осмотическими свойствами — привлекают воду в нижние отделы кишечника.

К ним относятся:

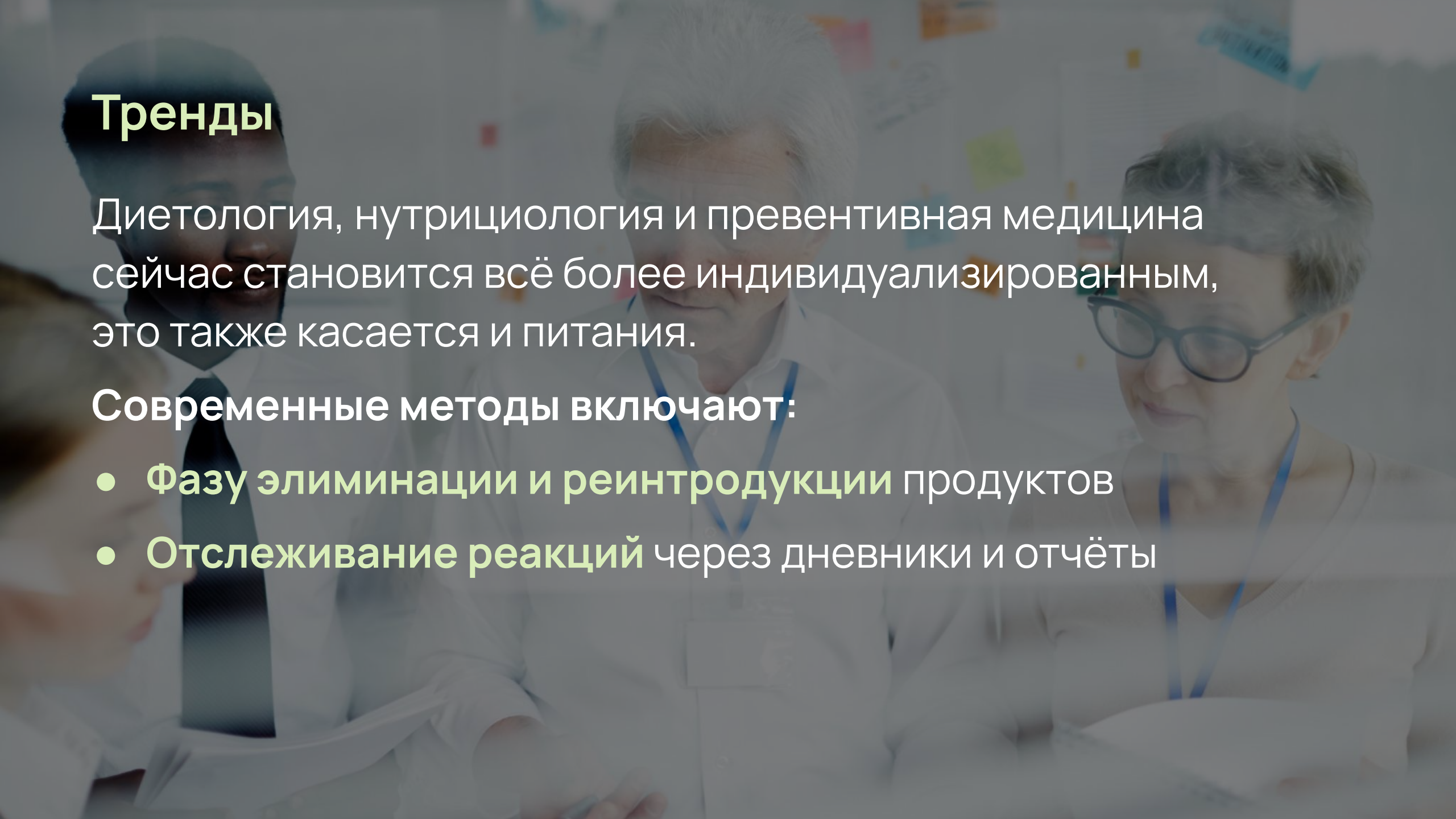
- **Олигосахариды** (фруктаны, галактаны) — содержатся в пшенице, бобовых, луке, чесноке, капусте.
- **Дисахариды** (лактоза) — присутствуют в молочных продуктах.
- **Моносахариды** (фруктоза) — содержатся в мёде и фруктах.
- **Полиолы** (сахарные спирты) — встречаются в некоторых фруктах и искусственных подсластителях.

Плюсы

- позволяет выявить индивидуальную чувствительность к сахарам

Минусы

- ограниченный потенциал диеты, так как не охватывает иммуннологическую реактивность



Тренды

Диетология, нутрициология и превентивная медицина сейчас становится всё более индивидуализированным, это также касается и питания.

Современные методы включают:

- **Фазу элиминации и реинтродукции** продуктов
- **Отслеживание реакций** через дневники и отчёты

Тесты на пищевую непереносимость

делают работу специалистов **эффективнее и менее трудозатратной** в разрезе индивидуального подбора питания.

Они не заменяют полностью исключающие диеты, но

- **Выявляют “скрытые” реакции**, которые сложно отследить вручную
- **Упрощают соблюдение** аутоиммунного протокола (АИП), ЭРД и других интервенций

Тесты становятся **удобным инструментом** для специалистов и клиентов — особенно в работе с хроническими состояниями и индивидуальной настройкой питания.

Кейсы

Кейс 1: трещины на пальцах и пищевая непереносимость

Клиент

Мужчина, 33 года, отец двоих детей, работает в высоком темпе.

Недавно получил повышение, на фоне которого стал замечать ухудшение самочувствия.



Основная жалоба

Уже **1,5 года трескается кожа на пальцах рук и ног**,
никто не может точно определить причину.

За это время клиент перепробовал множество методов:

- детокс-программы на смузи,
- лечение у дерматологов (включая гормональные мази и таблетки),
- антипаразитарные протоколы по результатам анализов

но **результатов не было**.

Доп. жалобы

- Постоянная усталость, даже после сна (7–8 часов)
- Нет энергии ни на спортзал, ни на семью
- Частые головные боли, изжога, вздутие живота, тяга к сладкому

Этап 1. Начало работы.

Скорректировали питание:

- Добавили в рацион **жиры, белки, овощи**,
- Убрали **алкоголь, кофе, молочные продукты**,
- Перестали перекусывать — **перешли на стабильные 3 приёма пищи в день**
- Клиент не готов к ЭРД, поэтому работаем с питанием мягко

Скорректировали образ жизни:

- Настроили **режим сна**,
- Добавили **горячую воду утром**,
- Улучшили **питьевой режим**.

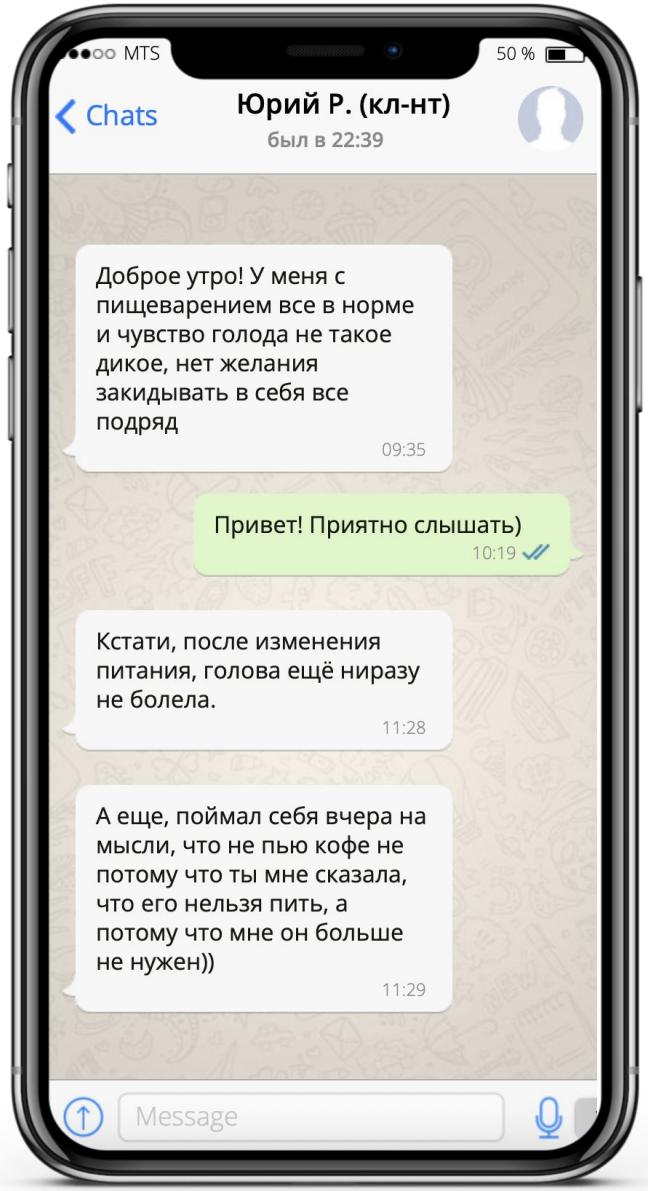
Этап 1. Начало работы.

Поддерживающая схема:

- Псиллиум и сок алоэ (поддержка ЖКТ),
- Витамин D, магний, витамины группы B,
- Магниевые ванны.

Через 1 месяц

- Вернулась энергия,
- Сон стал глубже,
- Ушла изжога и вздутие,
- Прошла тяга к сладкому и головные боли,
- Минус 3 кг — тело стало более рельефным.



Этап 2. Глубинная диагностика

Обследование: общий чек-ап.

- Обнаружены **проблемы с печенью и желчным пузырем (хлопья в желчном)**, повышенный билирубин.
- **Генетический тест показал синдром Жильбера (вариант 7/7)**

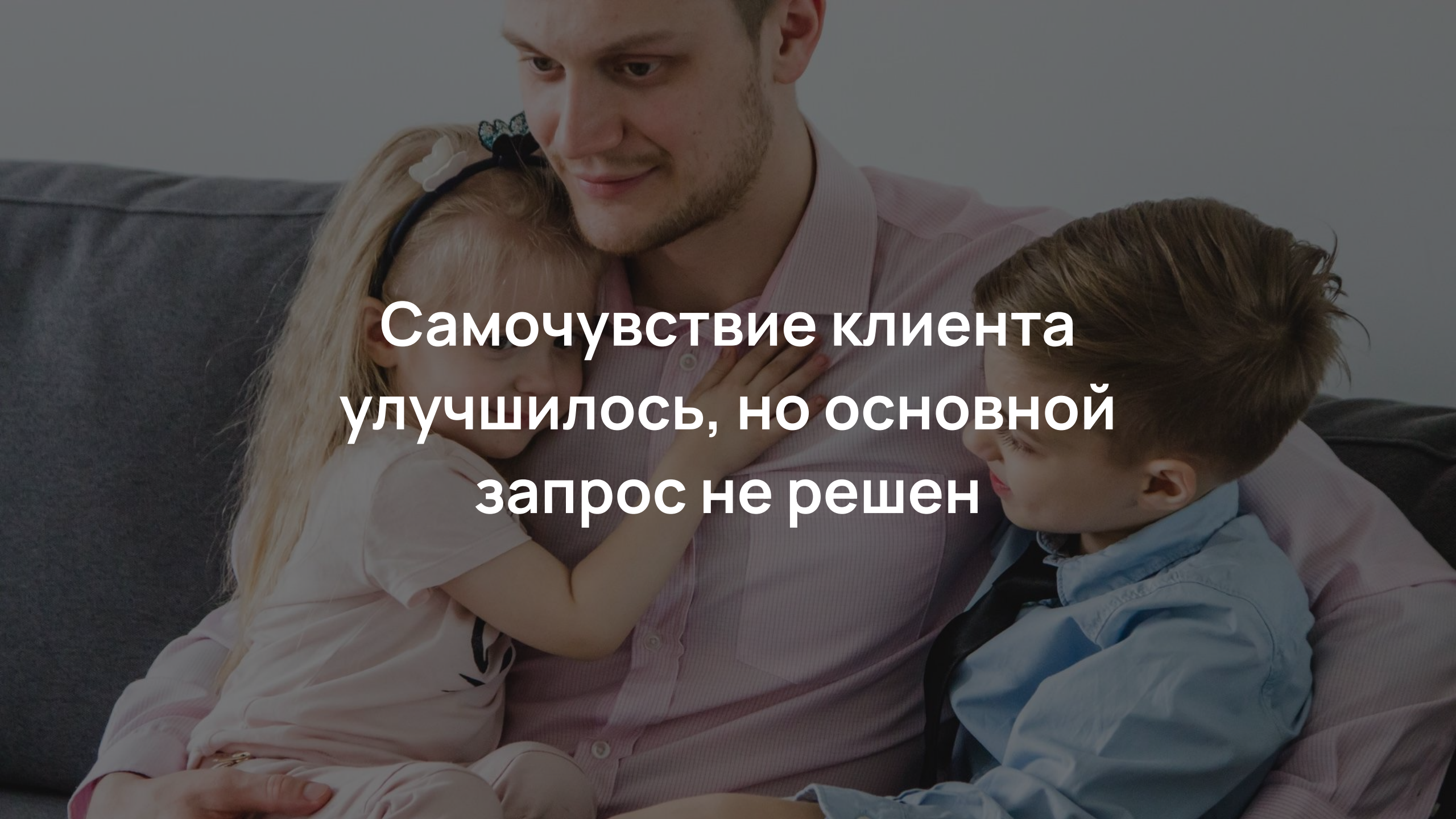
Этап 2. Глубинная диагностика

Дальнейшие действия:

- **Схема от гастроэнтеролога** — нормализация желчеоттока,
- Поддержка слизистых и мягкий детокс нутрицевтиками,
- Работа с остеопатом — снятие напряжения диафрагмы.

Через 3 месяца после начала работы

- **Трещины уменьшились**: остались на 4 пальцах из 20,
- Выявлено через дневник наблюдений: **трещины возникают при стрессе, вирусной нагрузке, перелётах**, заживают за неделю, появляются примерно раз в 2 недели.


Самочувствие клиента улучшилось, но основной запрос не решен

Неожиданное наблюдение после окончания работы

Через месяц после окончания работы клиент заметил, **что трещины полностью зажили через несколько дней**, когда он **случайно исключил яйца** (жена уехала, не успел купить).

Однако при **возврате триггерного продукта** трещины снова появлялись.



Вывод

По итогу работы есть стойкое улучшение общего состояния и кожных симптомов, несмотря на то, что полный результат по основному запросу **не достигнут**.

При наличии такой яркой симптоматики высока вероятность, что непереносимость есть ни одного продукта, а нескольких.

Поэтому исключение молока, кофе на более ранних этапах не дало устойчивый результат.

Кейс 2: высыпания на теле и отёчность

Клиент

женщина, 32 года, активный менеджер, часто летает по работе, живёт в высоком ритме.





Основные жалобы

- Высыпания на лице и теле,
- Отёчность,
- Лишний вес.

Сопутствующие симптомы:

- Выпадение волос,
- Вздутие, запоры,
- Тусклая кожа, мелкие морщинки,
- Тревожность, снижение энергии.

Анализы и диагностика

- **Воспаление в мочеполовой системе** (мелкие конкременты в почках на УЗИ и лейкоциты в моче)
- По тесту ХМС Осипова — **высокая бактериальная и грибковая нагрузка**

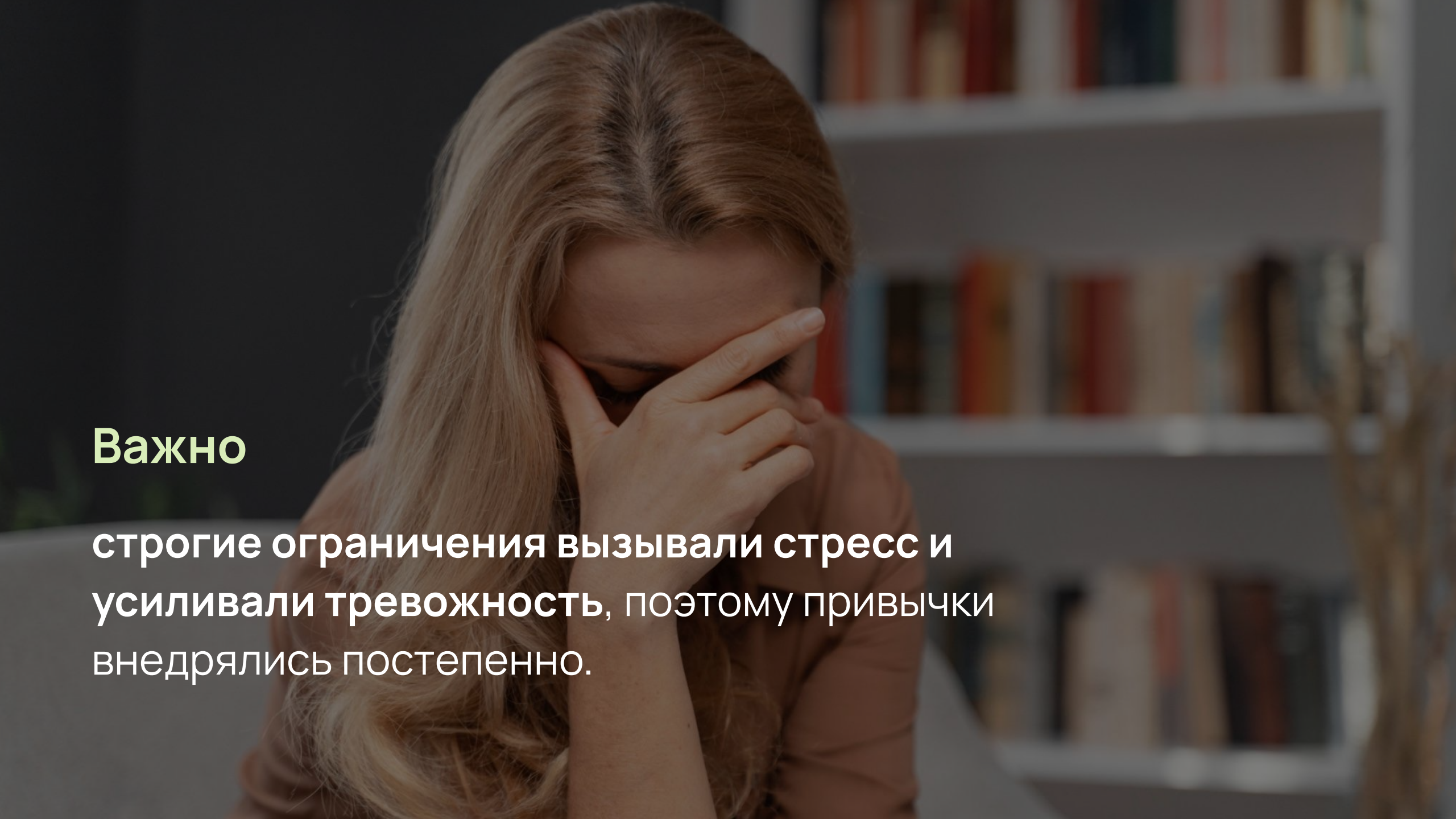
Этап 1. Начало работы.

Питание:

- Сократили **молочную продукцию, кофе, сладкое, фастфуд**,
- Добавили **белки, жиры, зелень, овощи**,
- Перешли к **трёхразовому питанию без перекусов**.

Жизнь и режим:

- Улучшили **сон**,
- Настроили **питьевой режим**,
- Подключили **базовые добавки**: витамины, ферменты, добавки для поддержки почек и печени, далее - 5R



Важно

строгие ограничения вызывали стресс и усиливали тревожность, поэтому привычки внедрялись постепенно.

Результат через 2 месяца

- **Отёчность значительно уменьшилась**, но зависит от уровня физической активности и приема добавок, а также уходит и возвращается без видимой на то причины.
- **Высыпания исчезают и появляются** также беспричинно, несмотря на соблюдение сбалансированного рациона
- **Улучшение по симптомам ЖКТ**: вздутие и запоры ушли, появился регулярный и комфортный стул

Этап 2. Расширенная диагностика

Сделали тест на пищевую непереносимость (IgG), где обнаружили **непереносимость**:

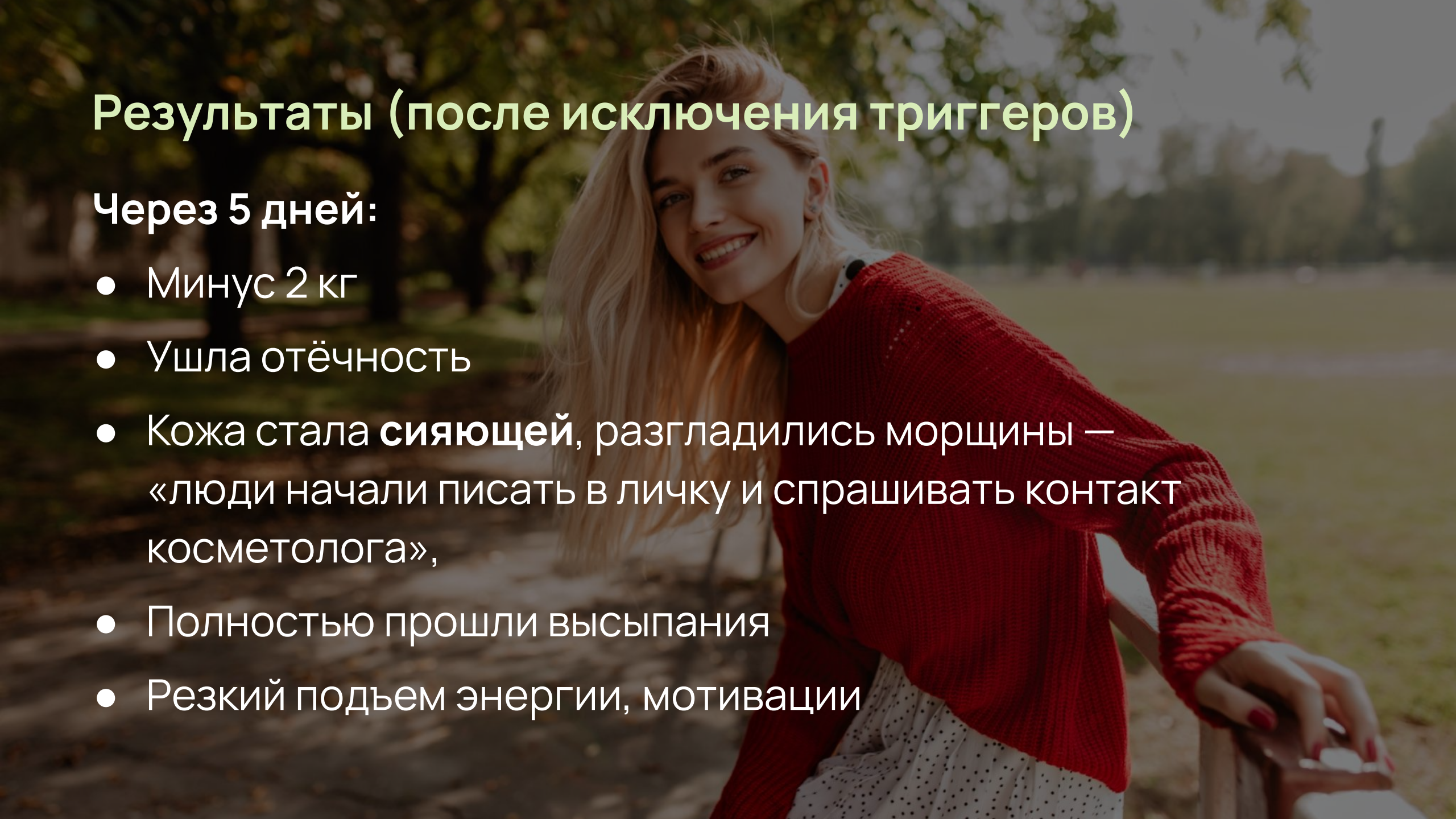
- яиц,
- овса,
- всей молочной продукции,
- арахиса,
- кофе и какао,
- некоторых орехов.

Все эти продукты регулярно присутствовали в рационе, особенно **овсянка и яйца**.

Этап 2. Расширенная диагностика

Сделан генетический тест (по запросу клиента), где были обнаружены:

- **Лактазная недостаточность LCT T/C** (сниженная активность фермента, т.е. молочные продукты с лактозой могут вызывать вздутие, дискомфорт и расстройства ЖКТ, но в ограниченном количестве могут перевариваться)
- **Метаболизм кофеина CYP1A2 A/A** (высокая активность фермента, а значит кофеин нормально выводится из организма)



Результаты (после исключения триггеров)

Через 5 дней:

- Минус 2 кг
- Ушла отёчность
- Кожа стала **сияющей**, разгладились морщины — «люди начали писать в личку и спрашивать контакт косметолога»,
- Полностью прошли высыпания
- Резкий подъем энергии, мотивации

Результаты (после исключения триггеров)

Через 3 месяца:

- Явная **связь между симптомами и питание**м, продукты, на которые есть пищевая непереносимость вызывают отечность и ухудшение состояние кожи
- **Снижение тревожности**, особенно после отказа от кофе и коррекции питания
- Мотивация сохраняется, рацион соблюдается стабильно

Планы на будущее

Продолжаем избегать продуктов, которые вызывают реакцию.

Добавляем поддерживающие средства:

- Для восстановления кишечника: глютамин, цитрусовый пектин, комплекс Healthy Gut, облепиховое масло и масло зародышей пшеницы, Омега-3 курсами.
- Для баланса микрофлоры: клетчатка, пробиотики и хлорофилл.
- Для восполнения дефицитов — хорошие мультивитамины.

Что дальше?

Через 3–4 месяца предложу повторно сдать тест и, если результаты улучшатся, начнём постепенно возвращать некоторые продукты: в первую очередь — орехи (кроме арахиса), возможно овсянку, яйца и кисломолочные продукты.

Буду внимательно следить:

- Сколько продуктов осталось в «красной» и «жёлтой» зоне,
- Что изменилось по тесту,
- Какие симптомы появляются или исчезают при возвращении продуктов в рацион.

Выводы

- Даже **при отсутствии симптомов ЖКТ** может быть выраженная пищевая непереносимость, проявляющаяся через кожу, вес, энергию, настроение.
- Исключение триггерных продуктов дало **мощный эффект по внешнему виду (anti-age эффект), снижению отечности и веса, а также повлияло на уровень энергии клиента**
- Улучшения проявляются **буквально за несколько дней** после изменения рациона.

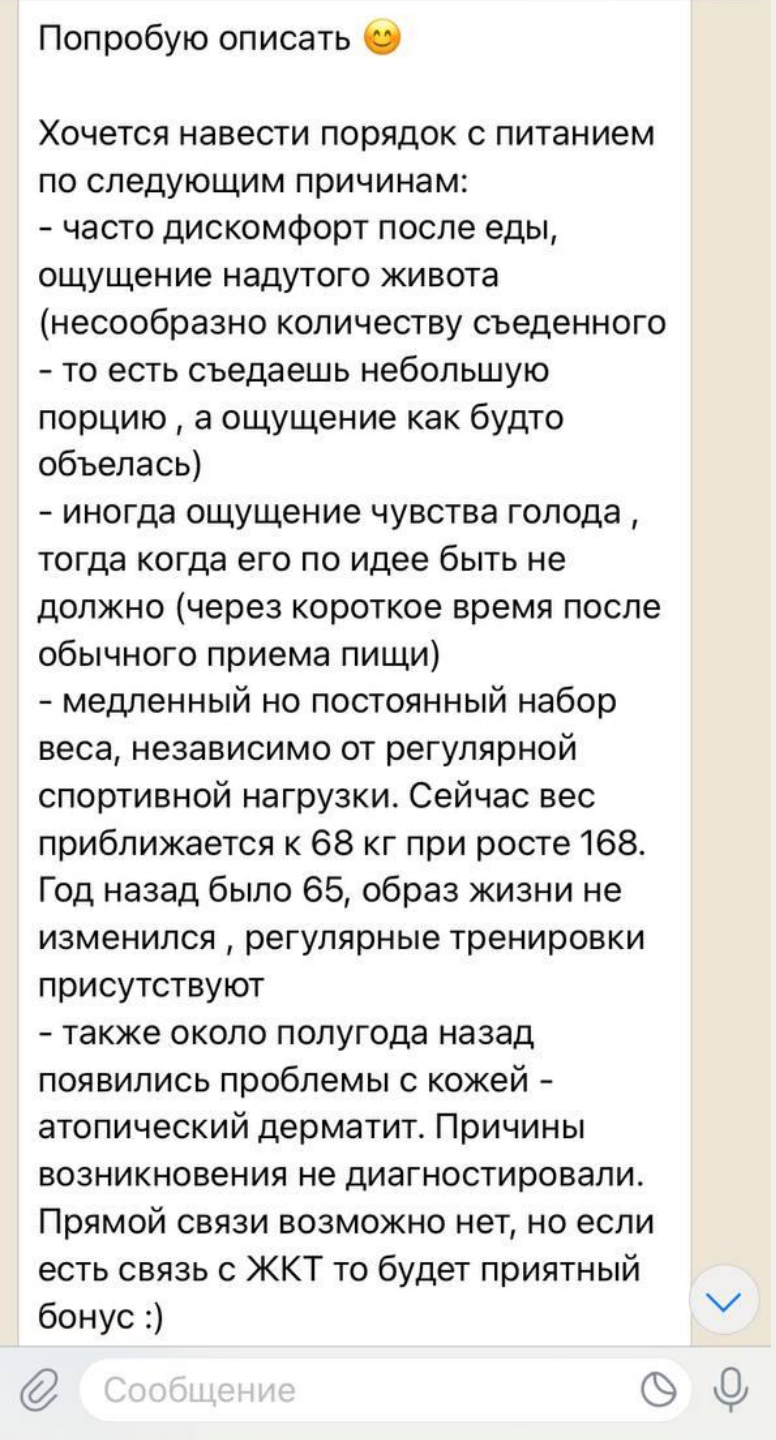
Кейс 3: дерматит и “вес стоит”

Клиент

женщина, 35 лет, ведет активный образ жизни.

Основные жалобы:

- Дерматит, особенно обостряется в поездках
- Вес стабильно растёт, несмотря на тренировки и хороший рацион за год прибавила 3 кг (с 65 до 68 при росте 168 см)
- Частый дискомфорт после еды, вздутие, быстрое возвращение чувства голода



Обнаружено при обследовании

- Признаки **аутоиммунного тиреоидита** (АИТ) — с 2021 года повышены антитела к щитовидке
- Полип в желчном пузыре (по УЗИ)
- **Дефицит витамина D**
- **Нарушения в микрофлоре кишечника**: высокая грибковая и бактериальная нагрузка, снижена полезная флора

Этап 1. Начало изменений.

Питание:

- Сократили кофе, убрали часть молочки и соусы, добавили больше овощей и медленных углеводов.
- Питание уже было относительно хорошим, без фастфуда.
- Изменения вводили постепенно — строгие ограничения вызывали тревожность и стресс.



Этап 1. Начало изменений.

Образ жизни:

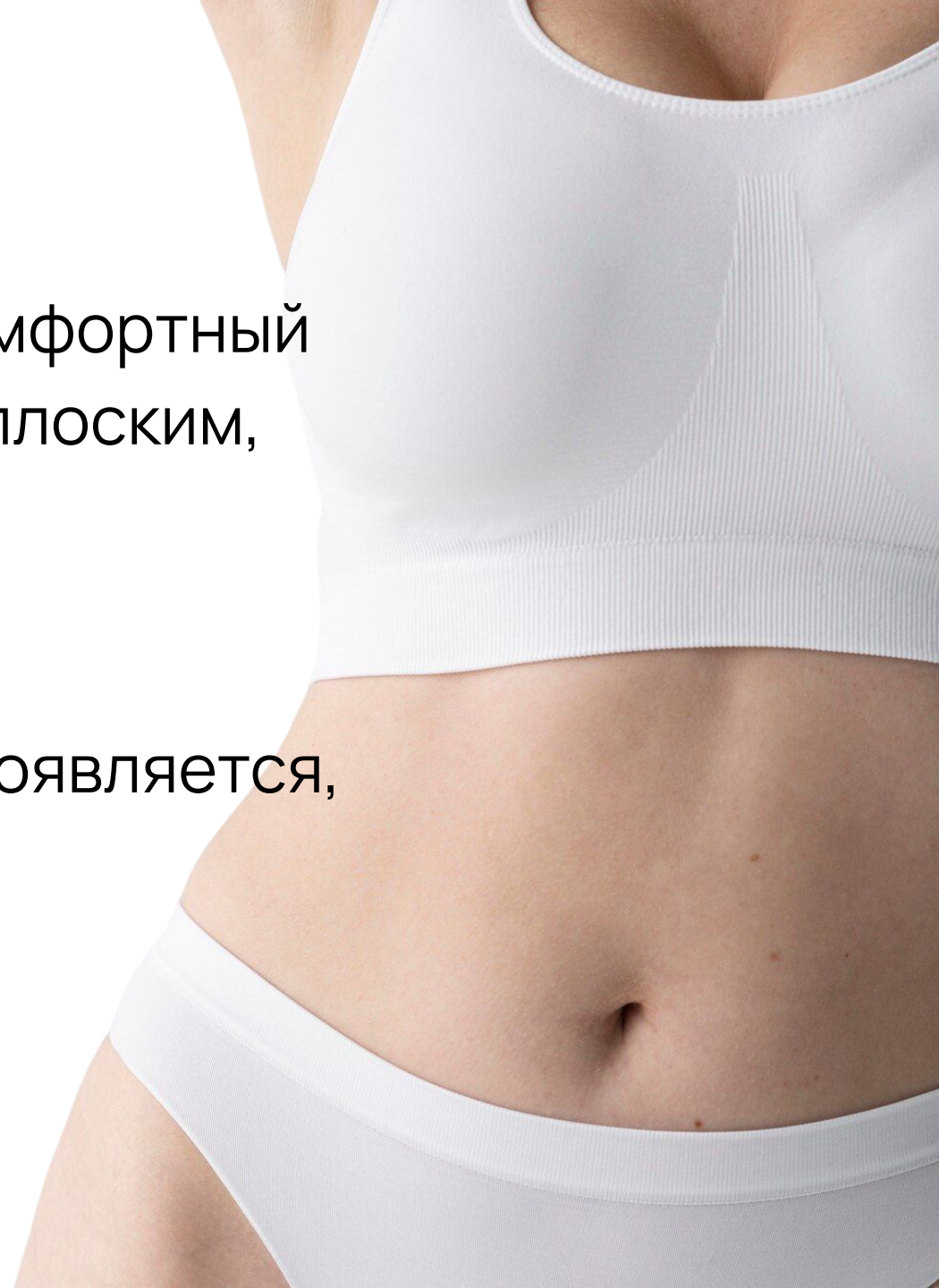
- Улучшили сон, ввели питьевой режим, добавили тёплую воду по утрам.

Базовая поддержка:

- Витамин D, магний, ферменты,
- Поддержка печени и желчного: TUDCA, глицин, NAC, лецитин,
- Подавление патогенной микрофлоры и восстановление микробиоты.

Результаты через 3 месяца

- ЖКТ полностью восстановился: комфортный стул, исчезло вздутие, живот стал плоским,
- Минус 3.5 кг, улучшился сон,
- УЗИ: **полипа больше нет**,
- **Кожа** — без изменений, дерматит появляется, но снимается кремами.



Дополнительная диагностика (через 4 месяца)

- Общий IgE — в норме
- Тест на пищевую непереносимость (IgG): выявлены реакции на молочные продукты (коровье, овечье), яйца, кофе, какао, миндаль, пивные дрожжи.
- Результаты ХМС подтвердили грибковый дисбаланс
- Антитела к щитовидке всё ещё повышены

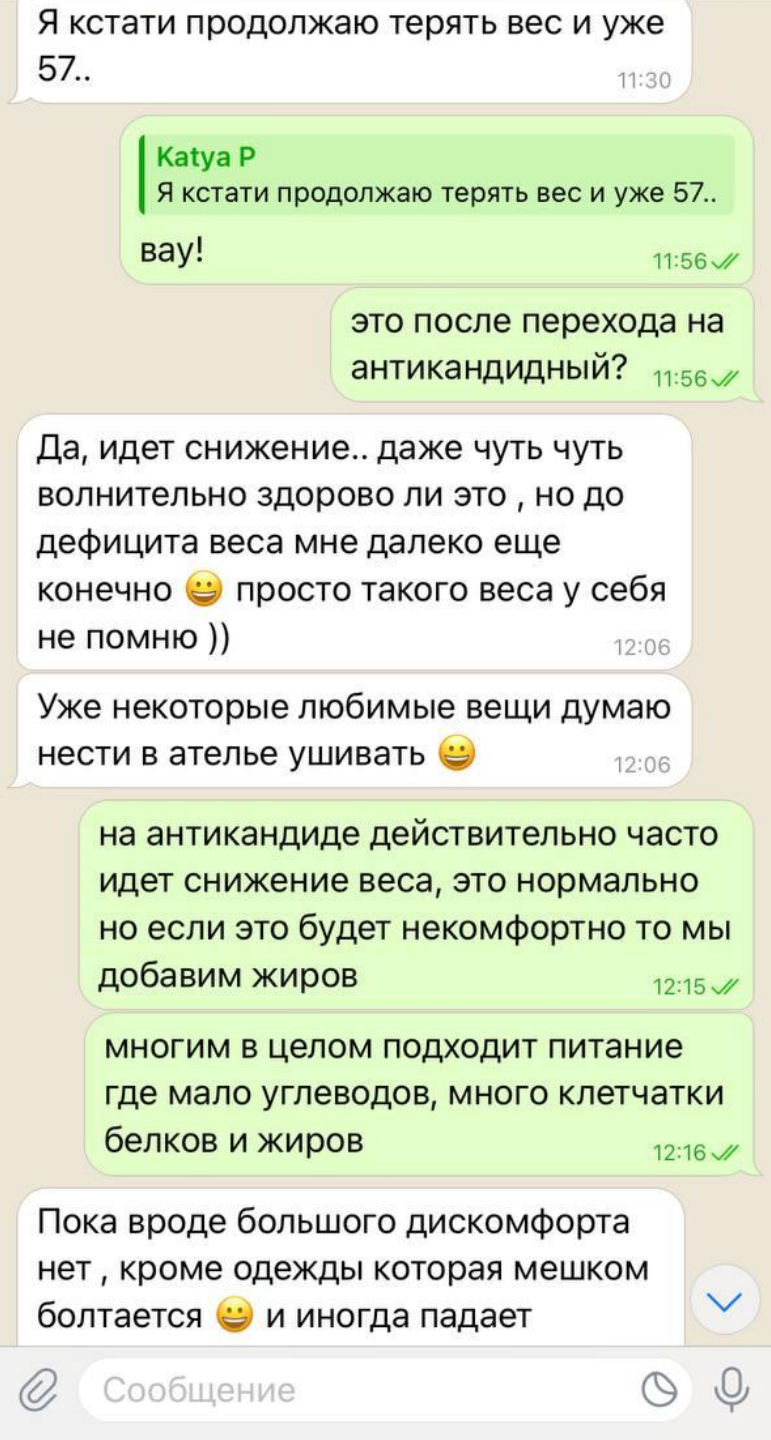
Этап 2. Корректировка рациона.

- Исключили триггерные продукты (молочку, яйца, кофе и др.), убрали сладкие ягоды и фрукты,
- Провели курс по снижению грибковой нагрузки (Хомоспоринов) и включили добавки для заживления слизистой кишечника.



Результаты через 3 месяца

- Минус ещё 6 кг — «такого не было со времён института»,
- Значительно уменьшилась аллергическая реакция (поллиноз),
- Кожа стала чище — пятна исчезают, когда нет погрешностей в питании,
- **Чёткая связь между нарушением диеты и дерматитом**, особенно после сладкого и триггерных продуктов,
- Антитела к щитовидке начали снижаться.



Результаты в динамике антител (АИТ)

1-ый месяц после начала работы

Дата взятия образца:	14.09.2024 10:52
Дата поступления образца:	14.09.2024 17:17
Врач:	15.09.2024 05:10
Дата печати результата:	15.09.2024

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АТ-ТГ	**13.00***	МЕ/мл	<4.11	Оборудование Abbott, Alinity i
АТ-ТПО	**141.3***	МЕ/мл	< 5.6	Оборудование Abbott, Alinity i

Сентябрь, 2024 г.

Результаты в динамике антител (АИТ)

6-ый месяц после начала работы

Фаза цикла:**Фолликулиновая**
Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

Дата/время взятия материала: **22/03/2025 10:30**
Дата доставки материала: **22/03/2025**
Номер заказа: **977998832601**
Номер образца: **977998832601**

Биохимические исследования

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к ТПО	↑ **21**	МЕ/мл	0-10

Март, 2025 г.

Результаты в динамике антител (АИТ)

8-ой месяц после начала работы

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к ТГ	0	МЕ/мл	0-20
Антитела к ТПО	↑ **18**	МЕ/мл	0-10

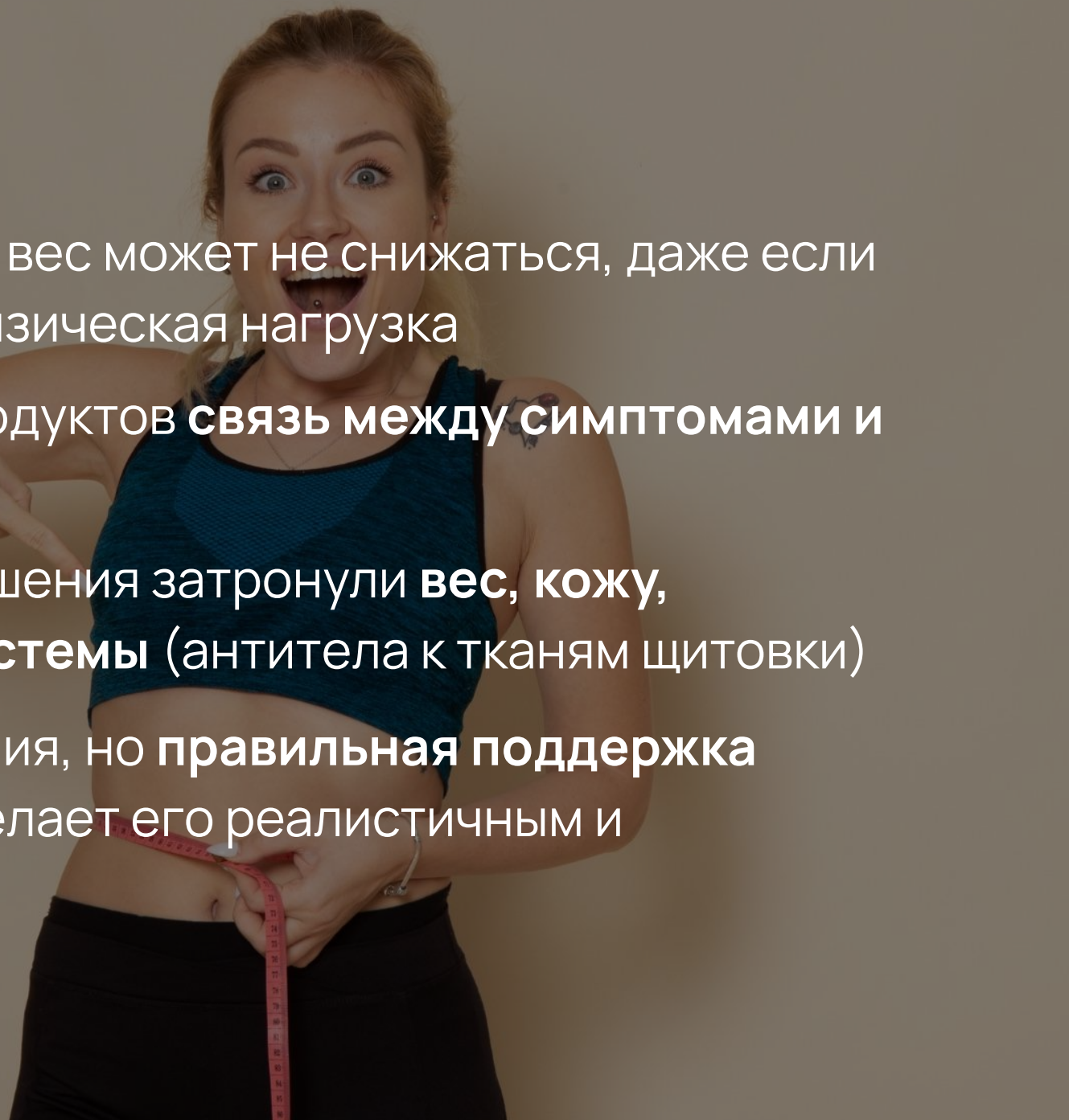
Июнь, 2025 г.

Текущий фокус

Работаем над **адаптацией к новому рациону**: иногда случаются «срывы» (кофе, сладкое). Чтобы соблюдать режим было легче, клиентке нужны:

1. Простые рецепты, проверенные на практике,
2. Списки покупок в привычных магазинах,
3. Полезные альтернативы «запрещённым» продуктам,
4. Списки для онлайн-доставки,
5. Подсказки по меню в кафе и ресторанах,
6. Чёткие правила — что есть вне дома, в поездках и в гостях.

Выводы



- При пищевой непереносимости вес может не снижаться, даже если калорийность в норме и есть физическая нагрузка
- Без исключения триггерных продуктов **связь между симптомами и едой может быть неочевидна**
- После коррекции рациона улучшения затронули **вес, кожу, энергию, работу иммунной системы** (антитела к тканям щитовки)
- Такой рацион требует привыкания, но **правильная поддержка** (удобные решения и замены) делает его реалистичным и эффективным

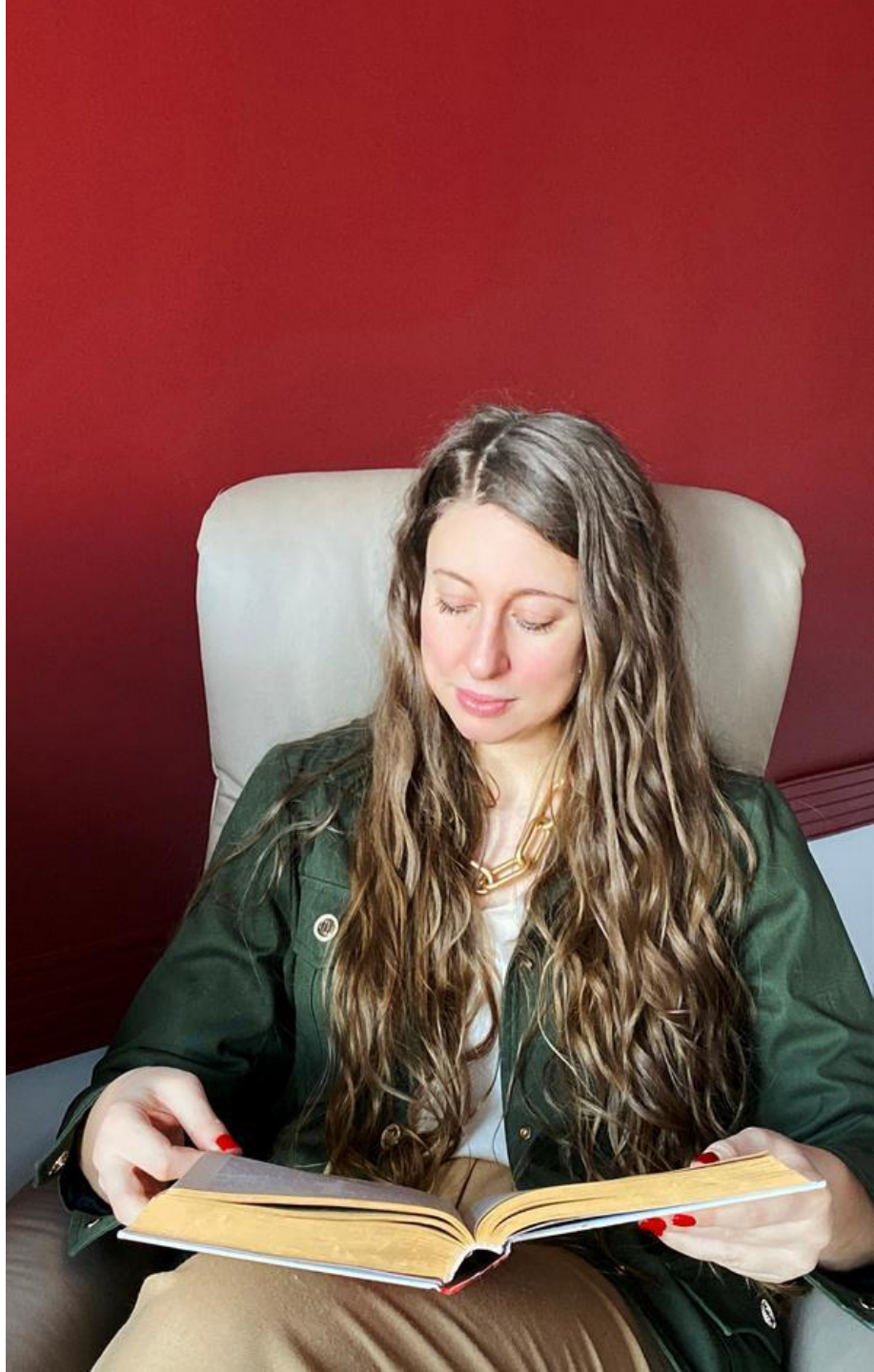
Мой личный кейс

Моя история

28 лет, офисный сотрудник с ненормированным графиком

Диагноз:

- С 12 лет — **аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз**
- **поллиноз** (сначала на берёзу, потом на злаки и травы)
- **Эмоциональное переедание**, булимия в ремиссии



Основные симптомы

- Постоянная усталость и сонливость (спала по 9–10 часов, но не чувствовала бодрости)
- Выпадение волос, кровоточивость дёсен, синяки
- Холодные руки и ноги
- Неприятные ощущения в животе: тяжесть, вздутие
- Молочница
- Повышенная тревожность, поверхностный сон
- Сильный ПМС

Анализы

- **Гормональная терапия** при гипотиреозе (L-тироксин) **давала недостаточный эффект** — рекомендовано увеличить дозу
- **Дефициты витаминов**: B6, B9, B12, D, железо
- **Микробиота нарушена**: грибки, вирусы, мало полезных бактерий
- **Атрофия слизистой желудка**, **низкий белок**
- **Низкий уровень кортизола** по 4м точкам, слюна (СУН)

Этап 1. Начало работы.

Изменения в питании были минимальными, начала с **добавления белка и зелени**. **Также, начала психотерапию**.

Помимо этого ввела добавки:
— Поддержка железа с помощью **кофакторов** (витамины B, C, лизин, лактоферрин)

— **Ферменты и кислоты** для пищеварения (бетаин, яблочный уксус)

— Работа с иммунологом по поводу молочницы.



Этап 2. Через 1–2 года

Результаты:

- Полностью ушли **проблемы с ЖКТ**,
- **Сон улучшился**,
- Энергии стало **намного больше**,
- Ушли **ПМС, выпадение волос**, кровоточивость дёсен и синяки.



Дополнительная диагностика

- ХМС Осипова: снова **преобладание грибков**, подавлена полезная флора,
- **Пищевая непереносимость по результатам теста на** молочную продукцию, пасленовые, кунжут, кофе, какао и тд. (все они были в рационе),
- **Повышенные антитела** к щитовидке сохранялись.

Корректировки по питанию

— Перешла к более **осознанному рациону**, уменьшила количество молочки, сладкого и фастфуда.

— Соблюдение питания по пищевым непереносимостям вызывает “срывы” и переедания



Результаты

- **Дозу гормональной терапии удалось сократить в 2 раза**,
- Удалось **поддерживать уровень железа без железосодержащих препаратов**,
- **Антитела к щитовидке снизились**,
- Ушли большинство симптомов, появилась энергия и стабильность.

Какие выводы?

- Даже **частичное соблюдение** рекомендаций даёт результат, если подход комплексный,
- Тест на пищевую непереносимость можно использовать как **персонализированный мягкий протокол** для людей с аутоиммунными диагнозами,
- **Важно работать не только с питанием, но и с психикой** — при пищевых срывах и тревожности нужна поддержка, гибкость и адаптация.

Интересное наблюдение

Результаты теста на пищевую непереносимость могут меняться спустя время

Мясо и птица

35	Утка
39	Курица
43	Кролик
54	Баранина
69	Индейка
78	Говядина
85	Свинина

Рыба и морепродукты

22	Тунец
39	Хек
51	Мидии
53	Угорь
57	Морской язык
63	Лосось
68	Палтус
68	Треска
73	Сардины
73	Устрицы
73	Лобстер
75	Креветки
77	Гребешок
87	Форель морская
99	Краб
140	Кальмар

Орехи и семена

56	Миндаль
81	Орех грецкий
90	Семена подсолнечника
92	Арахис
491	Кунжут

Молочные продукты и яйца

41	Яйцо куриное (желток)
53	Молоко козье
68	Яйцо куриное (белок)
68	Яйцо перепелиное
81	Молочная сыворотка
83	Брынза овечья
89	Молоко коровье
94	Сыр чеддер
104	Йогурт
105	Масло сливочное
109	Сыр швейцарский
118	Творог

Фрукты и ягоды

28	Груша
35	Слива
41	Лимон
53	Персик
54	Дыня
64	Апельсин
65	Клубника
70	Черника, Голубика
71	Виноград (смесь)
73	Финики
74	Арбуз
80	Банан
80	Яблоко
102	Клюква
158	Ананас
204	Киви
258	Грейпфрут

Овощи

23	Картофель
26	Свёкла красная
33	Оливки
44	Брокколи
48	Чечевица
50	Маш
53	Фасоль стручковая
55	Огурец
59	Баклажан
60	Соя
65	Капуста белокочанная
67	Зелёный горошек
68	Шпинат
69	Капуста цветная
70	Чеснок
71	Лук зелёный
73	Салат латук
73	Авокадо
75	Лук порей
77	Перец зелёный
83	Фасоль зерновая
85	Помидор
85	Петрушка
89	Тыква / Кабачок (смесь)
91	Лук репчатый
93	Имбирь
94	Морковь
96	Сельдерей

Зерновые

53	Рожь
53	Пшено (просо)
58	Пшеница
75	Ячмень (перловка)
76	Киноа
80	Кукуруза
81	Рис
94	Овёс
117	Гречка

Прочее

43	Глютен
55	Грибы (смесь)
61	Корица
65	Стевия
66	Чай чёрный
69	Дрожжи пивные
73	Сахар тростниковый
84	Дрожжи пекарские
85	Горчица
103	Мёд
109	Кандида
110	Табак
113	Казеин
159	Какао бобы
231	Перец чёрный
240	Кофе
297	Перец чили

2020 г.

Молоко и Яйцо

Буйволиное молоко	26.54 мкг/мл	Моцарелла	19.75 мкг/мл
Верблюжье молоко	13.83 мкг/мл	Овечий сыр	19.94 мкг/мл
Гауда	32.96 мкг/мл	Овечье молоко	28.74 мкг/мл
Камамбер	29.68 мкг/мл	Пармезан	18.77 мкг/мл
Козий сыр	10.37 мкг/мл	Пахта	43.14 мкг/мл
Козье молоко	16.03 мкг/мл	Перепелиное яйцо	31.93 мкг/мл
Коровье молоко	31.55 мкг/мл	Творог	31.04 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin)	46.41 мкг/мл	Эмменталь	18.12 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 5 *(Beta-Lactoglobulin)	42.68 мкг/мл	Яичный белок	43.32 мкг/мл
Молоко коровье Bos d 8 *(Casein)	25.36 мкг/мл	Яичный желток	44.83 мкг/мл
Перец (черный / белый / зеленый / красный / желтый)	29.64 мкг/мл	Ананас	43.57 мкг/мл

2024 г.

Зерновые и семена

Амарант	≤ 5.00 мкг/мл
Глиадин пшеницы Tri a Gliadin *	7.08 мкг/мл
Глютен	6.87 мкг/мл
Гречка	7.16 мкг/мл
Кедровый орех	≤ 5.00 мкг/мл
Киноа	≤ 5.00 мкг/мл
Кукуруза	≤ 5.00 мкг/мл
Кунжут	44.91 мкг/мл
Льняные семена	≤ 5.00 мкг/мл
Мак	7.03 мкг/мл
Овёс	17.07 мкг/мл
Подсолнечник	36.83 мкг/мл
Полба	9.32 мкг/мл
Просо	≤ 5.00 мкг/мл
Пшеница	11.50 мкг/мл
Пшеница однозернянка	8.61 мкг/мл
Пшеница польская	6.79 мкг/мл
Пшеница твёрдая	≤ 5.00 мкг/мл
Пшеничные отруби	6.88 мкг/мл
Рапс	39.42 мкг/мл
Рис	16.79 мкг/мл
Рожь	≤ 5.00 мкг/мл
Ростки пшеницы	≤ 5.00 мкг/мл
Семена конопли	≤ 5.00 мкг/мл
Семена люпина	≤ 5.00 мкг/мл
Семена тыквы	≤ 5.00 мкг/мл
Солод (ячмень)	6.61 мкг/мл
Спельта	8.34 мкг/мл
Ячмень	≤ 5.00 мкг/мл

2024 г.

Орехи

Бразильский орех	45.81 мкг/мл	Орех кола	≤ 5.00 мкг/мл
Грецкий орех	33.32 мкг/мл	Орех пекан	25.58 мкг/мл
Кешью	46.85 мкг/мл	Сладкий каштан	≤ 5.00 мкг/мл
Кокос	≤ 5.00 мкг/мл	Сыть (чуфа)	≤ 5.00 мкг/мл
Кокосовое молоко	8.04 мкг/мл	Фисташка	41.69 мкг/мл
Макадамия, орех	8.93 мкг/мл	Фундук	34.05 мкг/мл
Миндаль	35.84 мкг/мл		

2024 г.

Динамика антител к антигенам щитовидной железы (2019 г., без контроля питания)

Аутоантитела к антигенам щитовидной железы

Показатель	Результат	Норма	Единицы
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)	**386,0**	до 35,0	МЕ/мл
Антитела к тиреоглобулину (АТк ТГ)	**1700,0**	до 40,0	МЕ/мл

Февраль 2019 г.

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg)	**1592.4 ▲**	<4.1	МЕ/мл
Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)	**448.8 ▲**	<5.6	МЕ/мл

Сентябрь 2019 г.

Динамика антител к антигенам щитовидной железы (2021 г., с учетом контроля питания)

Оценка функции щитовидной железы: дополнение			
АТ-ТГ (кол.)	65.0	МЕ/мл	0 - 115
Дата исследования: 04.04.2021;			
АТ-ТПО (кол.)	***415.50++***	МЕ/мл	0 - 34
Дата исследования: 04.04.2021;			

Апрель 2021 г.

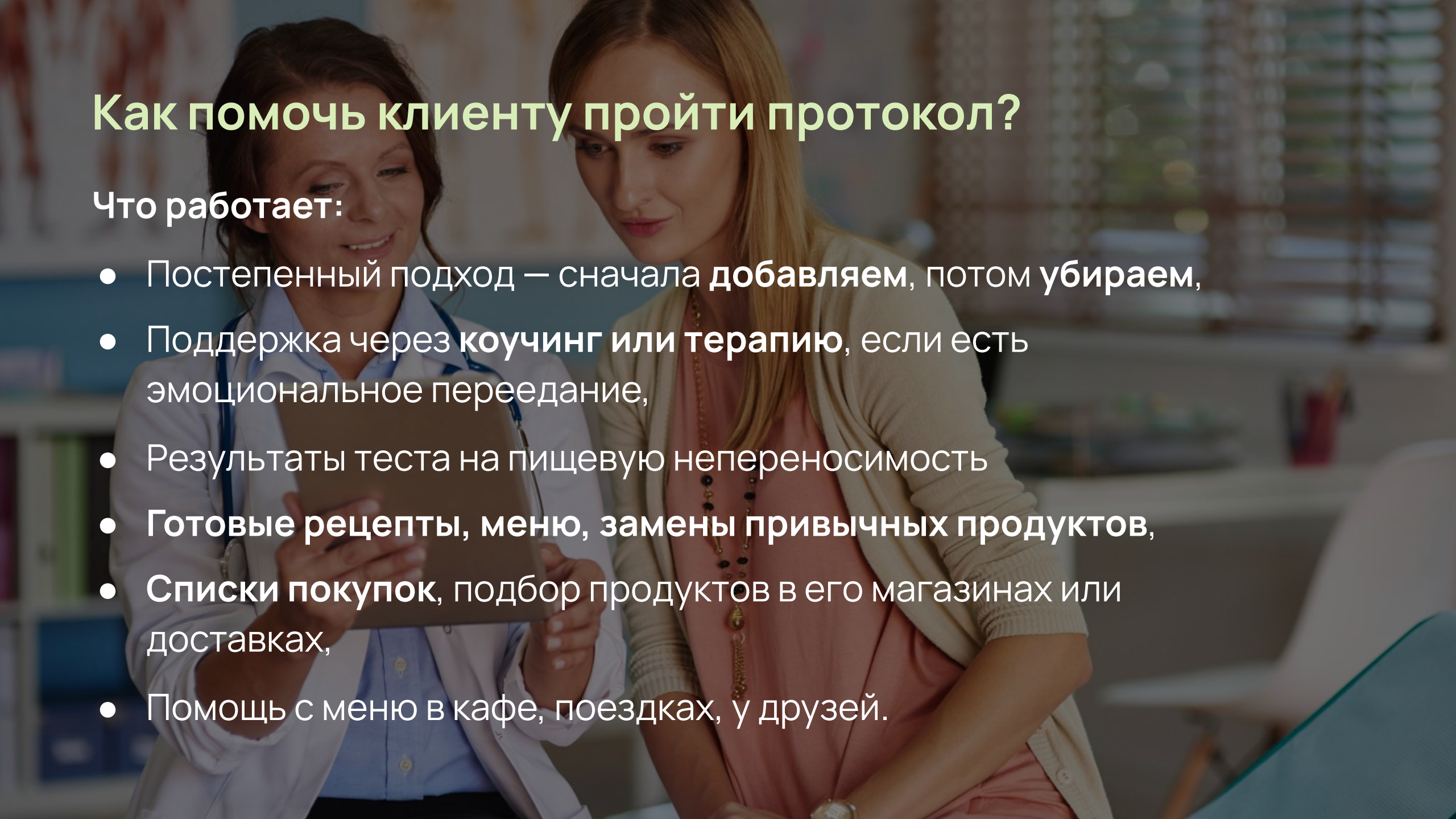
Динамика антител к антигенам щитовидной железы (2023 г. - 2025 г., без контроля питания)

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к ТГ	↑ **569**	МЕ/мл	0-20
Антитела к ТПО	↑ **449**	МЕ/мл	0-10

2023 г.

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к ТГ	↑ **773**	МЕ/мл	0-20
Антитела к ТПО	↑ **735**	МЕ/мл	0-10

2025 г.



Как помочь клиенту пройти протокол?

Что работает:

- Постепенный подход — сначала **добавляем**, потом **убираем**,
- Поддержка через **коучинг или терапию**, если есть эмоциональное переедание,
- Результаты теста на пищевую непереносимость
- **Готовые рецепты, меню, замены привычных продуктов**,
- **Списки покупок**, подбор продуктов в его магазинах или доставках,
- Помощь с меню в кафе, поездках, у друзей.

Чего лучше избегать?

- Давление и запугивание ("если не исключишь — никогда не вылечишься")
- Чрезмерные ограничения и жёсткие рамки — вызывают срывы, особенно при стрессовом перееданию
- Перебор экспериментов — лучше опираться на факты теста, чем "гадать на кофейной гуще"



Тест особенно полезен

если у клиента есть **хронические, "размазанные" симптомы**, которые не проходят несмотря на общее ЗОЖ и лечение. Например:

- Кожные проблемы (высыпания, экзема, дерматит),
- Постоянное вздутие, тяжесть после еды, нестабильный стул,
- Лишний вес, который не уходит при сбалансированном питании и тренировках,
- Усталость, тревожность, плохой сон, ПМС, мигрени, выпадение волос,
- Аутоиммунные заболевания, воспаления, повышенные антитела,
- Симптомы, усиливающиеся на фоне стресса и/или питания вне дома.



Важно

Особенно полезен, если клиент **уже "всё пробовал", но результата нет**, или **чувствует, что реакция на еду есть, но не может понять — на что именно**.

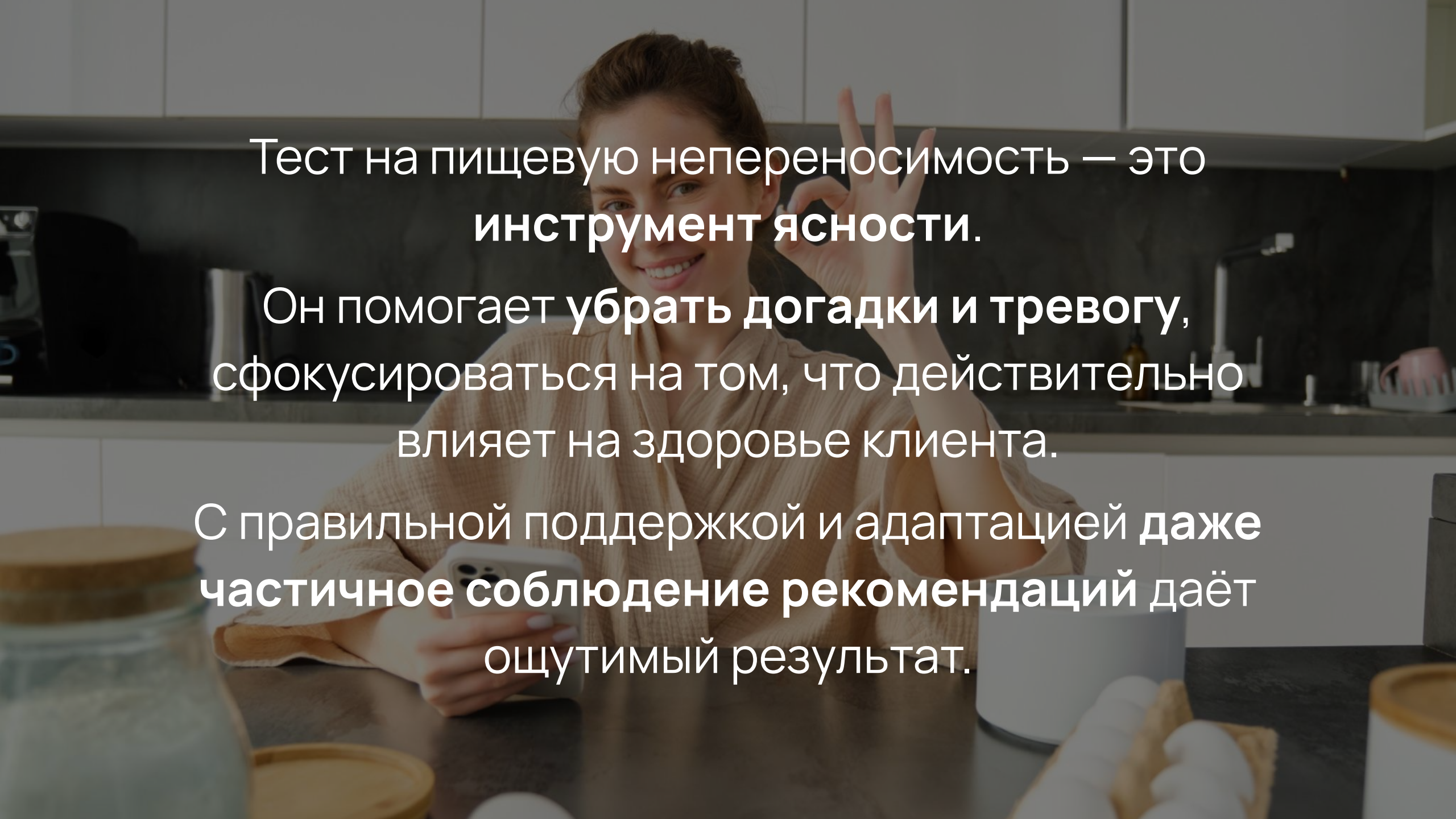
Когда стоит предлагать тест?

- Если **есть стойкие симптомы**, и базовые меры (сон, вода, питание, витамины) **не дали нужного эффекта**,
- Когда клиент **не готов к "диете вслепую"**, но готов попробовать персональный подход,
- После этапа **сбора анамнеза** и мягкого старта: рацион уже немного скорректирован, добавки введены — но проблема остаётся.

Не стоит давать тест сразу на первом шаге, особенно если у клиента слабая мотивация или тревожный фон — важно подготовить его психологически.

Какие результаты ждать?

- **Первые изменения** можно заметить уже через **5–10 дней** после исключения триггеров (меньше высыпаний, ушла отёчность, прибавка энергии, "легкость в теле"),
- Через **1–3 месяца** — улучшения по коже, весу, гормональному фону, ПМС, аллергическим реакциям,
- Через **3–6 месяцев** — **устойчивая динамика**: снижение антител, выравнивание настроения, восстановление микробиоты, улучшение усвоения нутриентов.



Тест на пищевую непереносимость — это **инструмент ясности**.

Он помогает **убрать догадки и тревогу**, сфокусироваться на том, что действительно влияет на здоровье клиента.

С правильной поддержкой и адаптацией **даже частичное соблюдение рекомендаций** даёт ощутимый результат.

В этом уроке мы

- Разобрали алгоритм работы с тестом на пищевую непереносимость на примерах из практики нутрициолога
- Поняли, каким клиентам особенно полезен этот тест
- Выяснили, в какой момент целесообразно рекомендовать тест, а в какой наоборот это не имеет смысла
- Обсудили кейсы и поняли какие результаты ожидать и в какие сроки
- Разобрали, как поддержать клиента для успешного прохождения протокола